

Fecha Última Actualización: 08-04-2022 18:27:07

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Silvia Del Carmen Brunet Rivas
Edad : 85a 6m 29d
Dirección : El Mirador 0108

Rut : 4.282.466-6
Fecha Nacto: 10/09/1936
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0310039
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 9623 3918

N° Epicrisis
297206

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 21/02/2022 20:03

Días Estadía: 46

Unidad de Egreso : Geriátrica

Fecha Egreso : 08/04/2022 18:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor abdominal + hematemesis (obstrucción intestinal)
Luego se traslada a UGA para rehabilitación

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

RESUMEN HOSPITALIZACIÓN

Nombre: Silvia del Carmen Brunet Rivas
Edad: 85 años
RUT: 4.282.466-6
Dirección: Pedro Nuñez Fernandez 1745. Villa Los Ciruelos. Puente Alto (vivía sola)
Teléfono tutor: 996233918
Fecha de Ingreso a CASR: 21-02-2022
Fecha de ingreso UGA: 18-03-2022
Persona que aporta datos: Ximena Brunet (sobrina)

BIOMÉDICOS

Antecedentes mórbidos: HTA, DM2, amaurosis y gastritis crónica
Antecedentes quirúrgicos: resección intestinal (obstrucción) febrero 2022; cataratas bilateral (enero 2022); caídas recurrentes (escaleras, baño.), fractura de brazo izquierdo en manejo ortopédico.
Alergias: no
Hábitos.
Tabaco: no OH: no Drogas: no
Inmunizaciones: vacunas COVID-19 (3 dosis). Influenza (-).
Nutricional: baja de peso previo a hospitalización, no cuantificado en cantidad.
Fármacos en uso: aumedicación, no recuerda con claridad de fármacos.

GERIÁTRICO

FUNCIONAL -> vivía sola

Situación basal funcional, Barthel 100/100, Lawton 8/8, hace costuras. No usa ayudas técnicas, trastorno de marcha (a veces), caídas múltiples el último año. Refiere que tras cirugía oftalmológica con dificultad en actividades instrumentales, pero lograba compensar.

COGNITIVO/MENTAL

Fecha Epicrisis : 08/04/2022 18:27

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 08-04-2022 18:27:07

Página 2 de 5

Escolaridad 4to medio, estudios técnicos de arte. Ocupación previa: costura, cuidados de su madre y hermana. Lectoescritura si. Sobrina refiere que ultimamente problemas de memoria. Algunas situaciones de riesgo: velas prendidas, gas no lo apaga. Antecedentes de patología psiquiátrica previa: no. Trastorno del sueño alterado, se duerme tarde y se levanta tarde. Historia de delirium previo durante estadía en UCI.

ANTECEDENTES SOCIALES

Estado civil soltera, no hijos, vivía sola en casa propia. Según relato de sobrina fue estafada con casa. Destino al alta sería donde su sobrina.

SÍNDROMES GERIÁTRICOS

Deterioro cognitivo: obs.

Demencia: obs.

Delirium: si

Constipación: si

Incontinencia/retención urinaria: si

Trastorno del peso: si

Sarcopenia: si

Trastorno de la marcha y caídas: si

Polifarmacia: si

Trastorno del ánimo: no

Trastorno del sueño: si

Fragilidad: si

Déficit sensorial: si, visual y auditivo.

Úlceras por presión: no

MOTIVO DE INGRESO: vómitos con sangre

Paciente con antecedentes antes mencionados, hospitalizada desde el 21/02/22 por una obstrucción intestinal por hernia interna que requirió resección intestinal de 1 metro (21/02). Ingresa a unidad de paciente crítico en donde permanece en ventilación mecánica y con requerimientos de DVA por 10 días, con buena evolución. Se logra weaning el día 4/03/26 y se traslada a unidad de agudo quirúrgico para continuar manejo.

Se solicita evaluación a equipo de neurología por persistir somnolienta (se sospecha delirium hipoactivo). Últimos exámenes del 12/03 muestran una anemia en mejoría (Hb 9.4, HTO 30.3), con parámetros inflamatorios estables (GB 8.39, PCR 11.5) y ELP normales. Sin mejoría, se solicita evaluación por equipo de geriatría, donde se evidencia paciente desorienta, con discurso disruptivo y CAM +, hidratada límite. Por todo lo anterior se decide traslado a Unidad Geriátrica de agudos para manejo y rehabilitación

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- Obstrucción intestinal
- o Resección intestinal
- VMI por 10 días
- HTA
- DM2

FUNCIONAL

- Previamente según relato de sobrina (que no vive con ella) era independiente en ABVD y AIVD

COGNITIVO/MENTAL

- Obs. deterioro cognitivo
- Trastorno de sueño
- Delirium

SOCIAL

- Paciente con red social presente

1. Hemodinamia: Estable. Objetivo de PA: <150/90. Se realiza ajuste progresivo en fármacos antihipertensivos. Actualmente

Fecha Epicrisis : 08/04/2022 18:27

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 08-04-2022 18:27:07

Página 3 de 5

con losartan 25 mg cada 12 hrs con cifrastensionales en rango. Mantener y seguir.

2. Infectológico: shock réptico abdominal y otras intercorrientes infecciosas en UCI, actualmente sin foco infeccioso ni elevación de PI. En aislamiento de contacto por E coli BLEE y A Baumannii resistente a carbapenémicos (no productor de carbapenemasas). Por hallazgos en RM compatibles con embolia séptica, infectología sugieren hemocultivar, incluir set de anaerobios e incubación prolongada (hasta la fecha negativos). FO descarta infección en ambos ojos. Paciente con PI bajos. sin fiebre o quiebre clínico, con HC I II (P; 25/03) UC (enterococo faecium VAN b), sin evidencias de infección actual. Sin indicación de antibióticos.

3. Nutricional: requirió soporte con NPT, actualmente vía oral + suplementos, con buena tolerancia pero hipoingesta, requiere asistencia en alimentación.

4. Digestivo: paciente con cirugía reciente por obstrucción intestinal secundaria a vólvulo, operada con resección + anastomosis. Acusa pujo defecatorio, en registro de enfermería paciente con ausencia de deposiciones por varios días. Se realiza TR con fecaloma impactado, Se realiza extracción manual + fleet enema con adecuada respuesta. Actualmente con laxante para asegurar deposiciones diarias. Mantener.

5. Oftalmología: evaluada por oftalmología 29/03/22, descarta infección de ambos ojos, se sospecha obstrucción de arteria central de la retina ambos ojos. Se sugiere Ecodoppler de carótidas que no evidencias estenosis significativas. Además solicita angiografía con Fluoresceína y control con exámenes en retina. Se realizará de forma ambulatoria.

6. Geriátrico: Paciente previamente frágil, pero con buen basal funcional descrito por familiar, en recuperación tras cuadro crítico y con múltiples secuelas post UPC. Ingresa a UGA con foco en rehabilitación.

a) Funcional: Con objetivos de rehabilitación, logra marcha con andador, buen desempeño, se baña en ducha con asistencia

b) Cognitivo: Paciente con delirium en resolución, en manejo ambiental. Se presenta con importante labilidad emocional por que se inicia manejo con sertralina el 24/03/22. Seguimiento.

c) Social: Se conversa con familiar responsable. Se plantea UHD a domicilio de sobrina para el viernes 8/4.

INDICACIONES GENERALES:

- PLAN: Se deriva para unidad de hospitalización domiciliaria para rehabilitación motora.
- Reposo Relativo
- Regimen licuado + líquidos claros hiposódico y diabético hiperproteico
- o Alimentación asistida
- Rehabilitación por kinesiólogo

INDICACIONES FARMACOLÓGICAS

- Losartan 50 mg. ¿ comprimido cada 12 hrs VO
- Omeprazol 20 mg. 1 comprimido al día VO
- Polietilenglicol 17 grs en 200 cc de agua cada 12 hrs VO
- Sertralina 50 mg. 1 comprimido por día VO

Fecha Epicrisis : 08/04/2022 18:27

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 08-04-2022 18:27:07

Página 4 de 5

- Paracetamol 500 mg. 2 comprimidos cada 8 hrs VO

CONTROLES:

- Programa de salud cardiovascular (control hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2)
- Oftalmología (seguimiento)
- Cirugía (seguimiento)

CONTROL URGENCIAS EN CASO DE:

- Pérdida de conciencia
- Confusión
- Dolor de pecho
- Dificultad respiratoria
- Debilidad en un lado del cuerpo
- Convulsiones.

Dr. Gonzalo Cifuentes Mardones (Residente de Geriatria USACH)
Unidad de Geriatria de Agudos
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Diagnóstico de Egreso

OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS - delirium, HTA, dm2

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

estable hdm, afebril, perdo requiere rehabilitacion motora.
Manejo ambiental en domicilio

Plan Post Alta

INDICACIONES GENERALES:

- PLAN: Se deriva para unidad de hospitalización domiciliaria para rehabilitación motora.
- Reposo Relativo
- Regimen licuado + liquidos claros hiposódico y diabético hiperproteico
- o Alimentación asistida
- Rehabilitación por kinesiólogo

INDICACIONES FARMACOLÓGICAS

- Losartan 50 mg. 1 comprimido cada 12 hrs VO
- Omeprazol 20 mg. 1 comprimido al dia VO
- Polietilenglicol 17 grs en 200 cc de agua cada 12 hrs VO
- Sertralina 50 mg. 1 comprimido por dia VO
- Paracetamol 500 mg. 2 comprimidos cada 8 hrs VO

CONTROLES:

- Programa de salud cardiovascular (control hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2)
- Oftalmología (seguimiento)
- Cirugía (seguimiento)

CONTROL URGENCIAS EN CASO DE:

- Pérdida de conciencia
- Confusión
- Dolor de pecho
- Dificultad respiratoria
- Debilidad en un lado del cuerpo
- Convulsiones.

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 08/04/2022 18:27

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:27

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 08-04-2022 18:27:07

Página 5 de 5

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Gonzalo Cifuentes Mardones

Becado/Residente

Jeniffer Alvarado Campoverde

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 08/04/2022 18:27

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:27

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar